

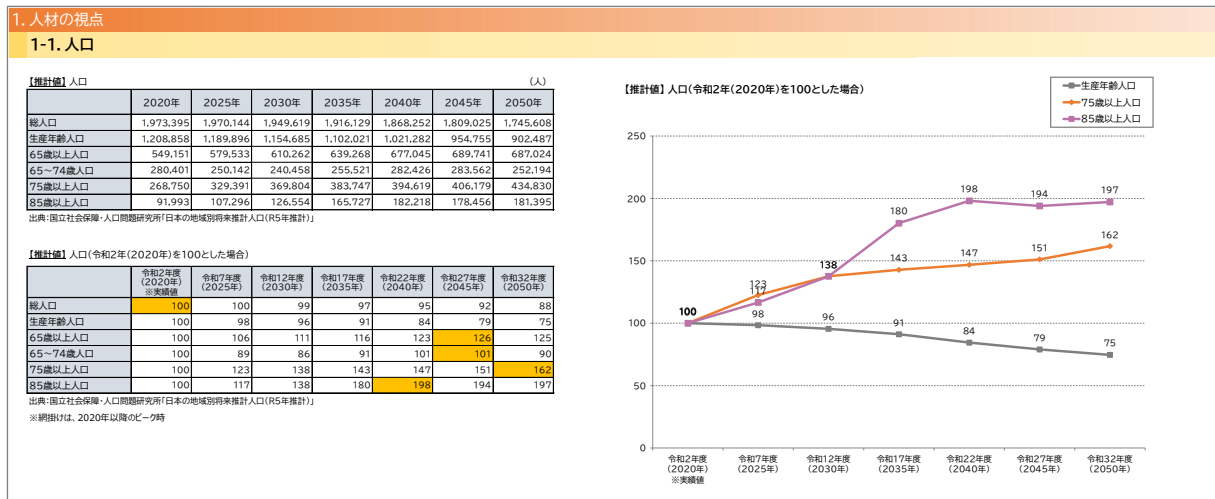
「(改修版)総合事業の充実に向けたワークシート」の説明書

1 人材の視点

1.1 人口

- ・ 総人口、および年齢階級別(生産年齢人口、65-74 歳人口、75-84 歳、85 歳以上)人口の将来に向けた推計値です。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)」の中位推計の値を自動表示します。
- ・ 主たる担い手となる生産年齢人口や、要介護認定率が高くなる 75-84 歳、85 歳以上の人口に着目するなど、基礎情報としてご覧ください。

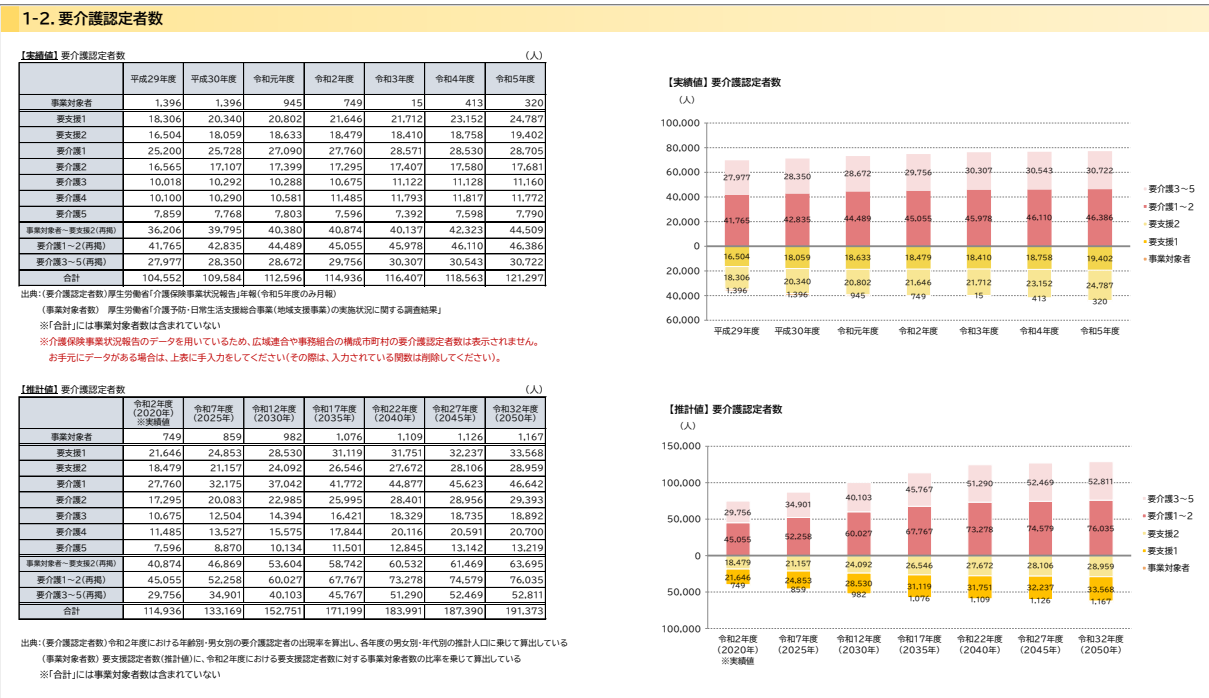
<1-1_人口>



1.2 要介護認定者数

- ・ 要介護度別の認定者数と事業対象者数の、実績値と推計値を表示します。
- ・ 要介護認定者数の推計値については、「介護保険事業状況報告」の「性別・年齢階級別の要介護認定率」(令和2年度)に、性別・年齢階級別の将来推計人口を乗じることで算出しています。
- ・ また、事業対象者数の推計値については、「要支援認定者数に対する事業対象者数の比率」(令和2年度)に、要支援者数の推計値を乗じることで算出しています。
- ・ いずれも令和2年度の実績値で作成した原単位を元に、将来の推計値を算出しています。

<1-2_要介護認定者数>



1.3 人材の視点

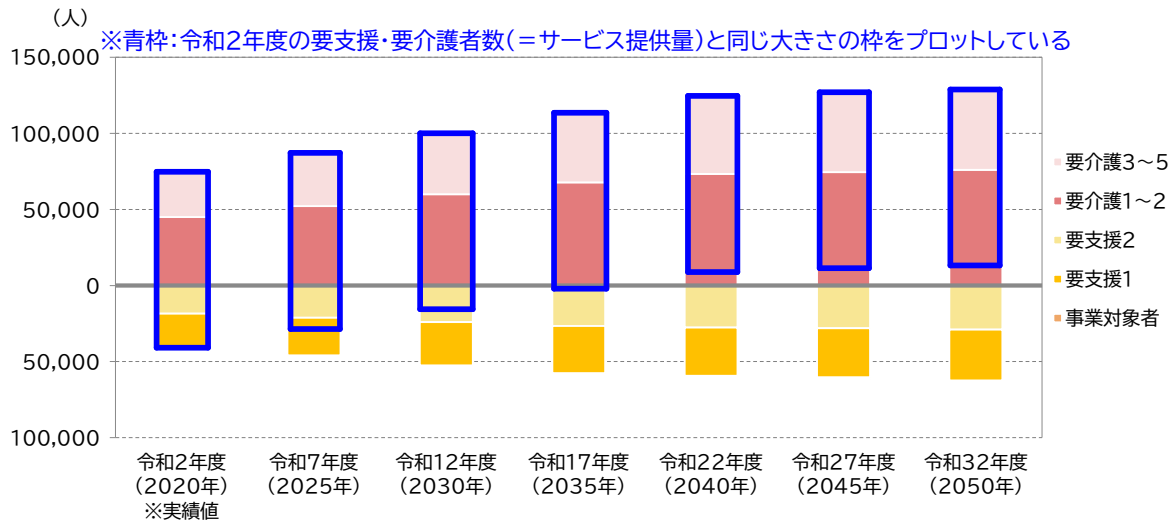
【確認の視点】

■ 自然体推計の結果に従って、今後も従前相当サービスを増やすことは可能か？

- ・ 在宅で生活する要介護者の増加や生産年齢人口の減少などを背景に、従前相当サービスを提供することができる専門職の確保が今後より一層困難になることを踏まえ、その他の多様なサービス・活動の必要性が高まることなどを確認
- ・ 従前相当サービスの利用が増加傾向にある地域では、介護保険事業計画において、今後も従前相当サービスの利用が過去のトレンド(自然体推計)に従って増加すると見込むケースが多くみられます。
- ・ しかしながら、在宅で生活する要介護者の増加や生産年齢人口の減少などを背景に、専門職の確保がより一層困難になると見込まれる地域においては、今後も従前相当サービスの利用者数を過去のトレンドに従って増やしていくことが本当に可能であるかという点について、慎重に確認することが必要です。
- ・ ここでは、「1-2. 要介護認定者数」で示した「要介護認定者数の推計値」の再掲と、「従前相当サービスの提供可能量が減少する中、増加するニーズにどのように対応するか？」についてのイメージを掲載しています。
- ・ (改修版)ワークシートにおいては、このような需要と供給制約を「可視化」し、事業計画の見込量等を適切に設定していくための情報を提示するものとして、需要と供給状況イメージを自動表示する機能を追加しています。
- ・ 具体的には、「要介護認定者数の推計値」をもとに、2020 年段階の需要を支える人材規模を固定(青枠)し、2050 年までの人材規模のイメージを市町村ごとに表示できるようにしています。また、2020 年時点の要支援・要介護認定者数に各年度の生産年齢人口の 2020 年に対する比率を乗じた大きさの枠(青枠)を令和7年度以降のグラフに重ねたイメージ(※生産年齢人口の減少を考慮したもの)も表示できるようにしています。

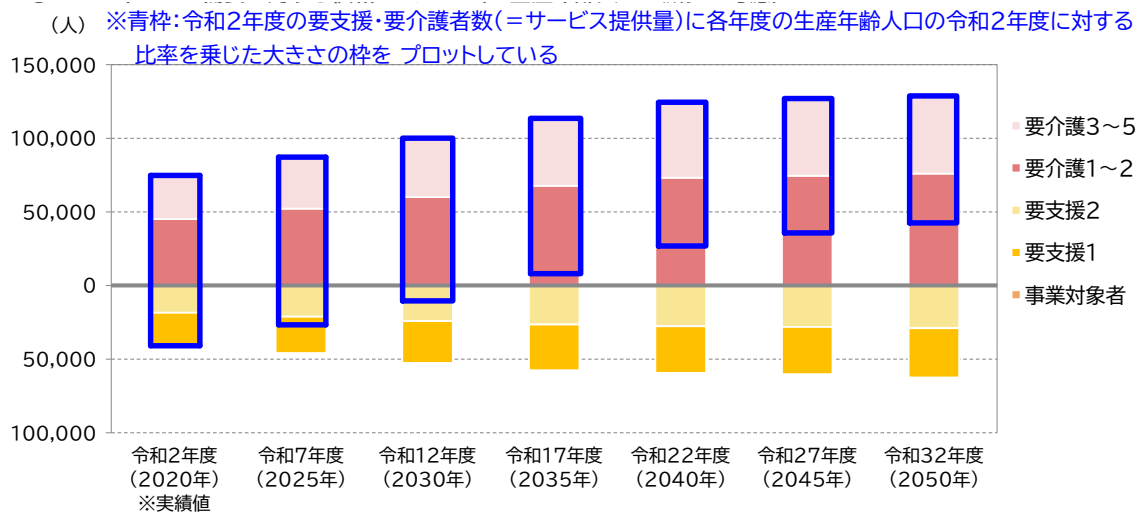
<ワークシート1-3. 2050年までの需要に対する供給のイメージ>

- 例えば、今後の要介護認定者数が下図のように推計されている場合、仮に専門職の人数や要支援・要介護者一人あたりに必要となる専門職の数が一定であるとする、2035年頃には要支援者等にサービスを提供できる専門職を十分に確保できない可能性が高いことが分かります。
- 将来的に施設の定員数が一定である場合、増加した要介護者は居宅サービスを利用することになります。しかし、限られた専門職は在宅で生活する要介護者にサービスを提供する必要があるため、要支援者等へのサービス提供を継続することが困難になる可能性が高いと考えられます。



<ワークシート1-3. 2050年までの需要に対する供給のイメージ

(※生産年齢人口の減少を考慮)>



- 将来に向けて施設の定員数が一定の場合は、増加した要介護者は居宅サービスを利用することになりますが、限られた専門職は在宅で生活する要介護者にサービスを提供する必要があるため、要支援者等にサービスの提供を続けていくことは困難になる可能性が高いとえます。
- 多様なサービス・活動は、必ずしも現状の従前相当サービスを代替するものとして位置づけられるものではありませんが、このような要介護者を含めたニーズの増加や供給制約(人材確保の視点)から、多様なサービス・活動の必要性を確認し、必要な取組や見込量などを介護保険事業計画に反映していくことも求められます。

<3_人材の視点>

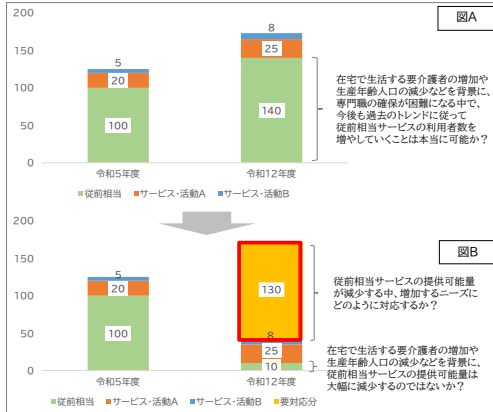
1-3. 需要に対する供給

★確認の視点

- 自然体推計の結果に従って、今後も従前相当サービスを増やすことは可能か？
- ・ 在宅で生活する要介護者の増加や生産年齢人口の減少などを背景に、従前相当サービスを提供することができる専門職の確保が今後より一層困難になることを踏まえ、その他の多様なサービス・活動の必要性が高まることを確認

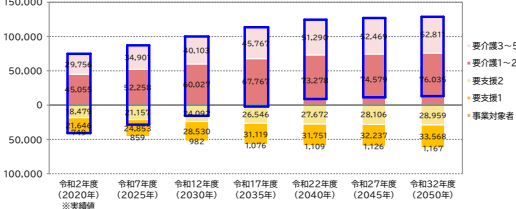
- ・ 従前相当サービスの利用が増加傾向にある地域では、介護保険事業計画において、今後も従前相当サービスの利用が過去のトレンド（自然体推計）に従って増加すると見込めるケースが多くなります。
- ・ しかしながら、在宅で生活する要介護者の増加や生産年齢人口の減少などを背景に、専門職の確保がより一層困難になると見込まれる地域においては、今後も従前相当サービスの利用者数を過去のトレンドに従って増やしていくことが本当に可能であるかという点について、慎重に確認する必要があります。
- ・ ここでは、「1-2_要介護認定者数」で示した「要介護認定者数の増計画」の再掲と、「従前相当サービスの提供可能性が減少する中、増加するニーズにどのように対応するか」についてのイメージを掲載しています。
- ・ 仮に、今後要介護者数が増加する場合、将来的に要支援者等にサービスを提供できる専門職が確保できない可能性があります。
- ・ 多様なサービス・活動は、必ずしも現状の従前相当サービスを代替するものとして位置づけられるものではありませんが、このような要介護者を含めたニーズの増加や供給制約（人材確保の観点）から、多様なサービス・活動の必要性を確認し、必要な取組や見込量などを介護保険事業計画に反映していくことも求められます。

◆ 従前相当サービスの提供可能性が減少する中、増加するニーズにどのように対応するか？（イメージ）



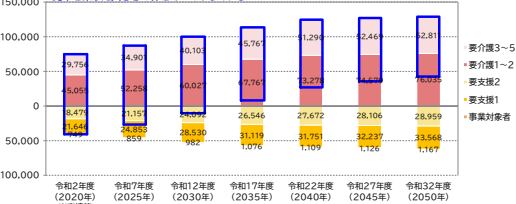
①2050年までの需要に対する供給のイメージ

※青枠:令和2年度の要支援・要介護者数(=サービス提供量)と同じ大きさの枠をプロットしている



②2050年までの需要に対する供給のイメージ(※生産年齢人口の減少を考慮)

※青枠:令和2年度の要支援・要介護者数(=サービス提供量)に各年度の生産年齢人口の令和2年度に対する比率を乗じた大きさの枠をプロットしている



2 財政の視点

2.1 制約条件の中における持続可能性

【確認の視点】

■ 総合事業の総事業費は、今後も上限の範囲内に収まるか？

- ・ 基本の上限額に対する、これまでの総事業費の額は？
 - ・ 内訳としてどの費目が増加・減少しているか？
 - ・ 今後、過去の実績(もしくは 80 歳以上 or 85 歳以上人口の伸び)に応じて総事業費が推移した場合、基本の上限額に収まる見込みか？
-
- ・ 保険者から国・都道府県に報告する「地域支援事業交付金事業実績報告書_ファイル」や「総合事業上限算定の手引き_ファイル」を、Excel マクロで読み込み自動入力します。
 - ・ ただし、これらのファイルは年度によってファイルの様式が異なるため一度に読み込むことができません。次ページに記載する方法に従い、それぞれ該当するファイルを格納するフォルダを作成した上で、ツール内のボタンを押してファイルを読み込んでください。
 - ・ 令和7年度以降の事業費総額の推計が示されていますが、1つは「令和元年と令和6年の実績値を結んだ線」をそのまま将来に延長した推計です。これは、令和2年度以降、新型コロナウイルスの影響で多くの市町村で事業費が減少したため、その影響を避けるため、令和元年度から令和6年度の変化に着目した推計を行ったものです。
 - ・ また、もう1つは「令和6年度実績に、80 歳以上(もしくは 85 歳以上)人口の伸び率を乗じた」推計です。これは、基本の上限額が75歳以上人口の伸びに準じて設定される一方で、団塊の世代全員が75歳以上となる令和7年度以降は、実際の事業費が80歳以上(もしくは85歳以上)人口の伸びに影響を受ける可能性があるためです。
 - ・ 実績値については、基本の上限額と総事業費を比較し、「超過している」・「概ね同額」・「ある程度余裕あり」といった視点で確認をし、各費目の内訳などを見ながら、その要因がどこにあるかを確認します。
 - ・ また、推計値については、既述のとおり複数パターンで総事業費の将来推計を行っています。将来に向けて総事業費が基本の上限額に収まる見込みであるかを確認し、収まらない場合は、各サービス・活動の「利用者数」や「単価」などを確認しながら、どのような対応が必要かを検討します。

<2-1. 制約条件の中における持続可能性>

2-1. 制約条件の中における持続可能性

★確認の視点

■ 総合事業の総事業費は、今後も上限の範囲内に収まるか？
・ 基本の上限額に対する、これまでの総事業費の額は？

- ・基本の上限額に対する、これまでの総事業費の額は？
- ・内訳としてどの費目が増加・減少しているか？
- ・今後、過去の実績（もしくは80歳以上or85歳以上人口の伸び）に応じて総事業費が推移した場合、基本の上限額に収まる見込みか？

※ 以下のボタンを押してファイルを読み込みます。

詳細は、シート「ファイルの読み込み方(★2-1について)」をご確認ください。

◆ 各種実績額等の転記（平成27年度～令和5年度分）

- ①平成27年度～令和2年度分を読み込む ②令和3年度～5年度分を読み込む

◆ 各種上限額の転記（平成27年度～令和5年度分）

- ③平成27年度～令和3年度分を読み込む

◆ 各種実績額等、各種上限額の転記（令和6年度分）

- ⑤令和6年度分を読み込む

【（前バージョン）ワークシートで取り込んだ市町村向け】 各種実績額等、各種上限額の転記

(平成27年度～令和5年度分)

(前バージョン) ワークシートから転記

※基本の上限額：旧原則の上限額（令和6年8月以降、名称が変更されています）

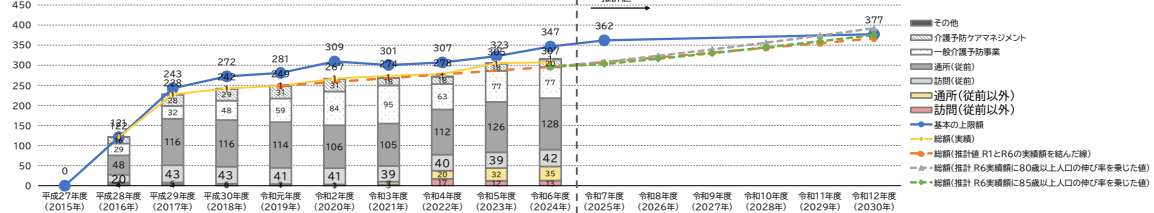
※介護予防給付金体の伸びを考慮する上限額:旧選択可能な上限額(令和6年8月の改正以降、名称が変更されています)

は、各年度における各種上限額(143行～146行)の最大値を表す

(四)

	実績										累計						
	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	
最終的な上乗率(基準率)	#N/A	158,324,990	247,736,915	272,182,881	284,609,224	310,974,906	334,827,120	309,306,584	322,542,088	324,566,919	0	0	0	0	0	0	
最終的な上乗率 の差(上乗率)		120,840,282	247,736,915	272,182,881	280,916,238	309,434,249	330,588,296	307,130,004	322,942,088	348,596,919	361,880,279	0	0	0	0	377,397,444	
最終的な上乗率 の差(上乗率) の差(上乗率)		123,758,227	247,736,915	272,182,881	280,916,238	309,434,249	330,588,296	307,130,004	322,942,088	348,596,919	361,880,279	0	0	0	0	377,397,444	
特約口	0	158,502,348	265,346,440	0	0	0	-268,796,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上乗率-総額(実績)	#N/A	787,281	15,520,523	30,254,039	31,930,994	42,887,740	26,805,853	49,609,917	35,302,568	40,384,162	0	0	0	0	0	0	
総額(実績)計上乗率の上乗率 を補正した額									296,182,429	307,971,725	319,761,022	331,550,371	343,339,615	355,128,912	366,918,202	377,397,444	
総額(実績)計上乗率の上乗率 を補正した額 の差(上乗率)									296,182,429	307,971,725	319,761,022	331,550,371	343,339,615	355,128,912	366,918,202	377,397,444	
総額(実績)計上乗率の上乗率 を補正した額 の差(上乗率) の差(上乗率)									296,182,429	307,971,725	319,761,022	331,550,371	343,339,615	355,128,912	366,918,202	377,397,444	
総額(実績)	#N/A	121,628,118	227,616,392	242,128,842	240,625,242	266,546,500	273,782,426	278,239,514	305,287,540	307,287,540	0	0	0	0	0	0	
総額(実績)		15,503,462	42,781,370	42,589,706	40,929,520	40,838,396	39,425,727	40,140,163	38,997,272	42,168,238	0	0	0	0	0	0	
総額(実績)		48,436,037	115,991,973	115,962,382	113,824,718	104,443,635	105,390,321	112,441,000	125,609,789	127,923,043	0	0	0	0	0	0	
総額(実績)		3,375,430	3,545,311	407,381	664,891	587,241	587,241	712,755	12,356,794	12,356,794	0	0	0	0	0	0	
総額(実績)		4,268,886	4,552,045	4,556,833	3,838,226	1,520,133	7,289,755	20,069,020	31,738,254	35,262,207	0	0	0	0	0	0	
一階部分の総額		29,275,750	32,023,694	48,238,541	58,979,343	84,398,288	94,884,713	63,342,689	77,253,552	76,722,200	0	0	0	0	0	0	
一階部分の総額		16,311,146	16,311,146	78,808,113	30,774,232	30,919,073	18,048,076	18,048,076	18,048,076	18,048,076	0	0	0	0	0	0	
一階部分の総額	#N/A	297,406	486,852	1,475,946	771,302	819,734	922,059	1,145,427	1,289,841	1,416,669	0	0	0	0	0	0	

(百万円)



◆ファイルの読み込み方

- 国・都道府県への毎年度の報告時に使用した「地域支援事業交付金事業実績報告書」および「総合事業上限額算定の手引き」(ともに Excel ファイル)から、地域支援事業の各種実績額や上限額等を読み込み、ワークシートに転記します。
- 読み込みは5回に分けて行います。そのため、まずは以下の表のとおり5つのフォルダを作成し、各フォルダに必要なファイルを格納します(不要なファイルは格納しないでください。また、ファイルの読み込みの際は、ファイルを閉じた状態にしてください)。その後、ワークシートにあるボタンを押して、指示に従って対象のフォルダを選択し、データを転記します。
- なお、例えば平成 28 年度に総合事業に移行した場合は、平成 27 年度のファイルは必要ありません(また、過去のファイルが見つからない場合、途中の年度からのファイルをご用意いただければ、ファイルのある年度の数値のみを転記することが可能です)。

【使用にあたっての注意事項】

- ・ ボタンを押して読み込みを行うごとに、表に転記される数値は上書きされます。
- ・ フォルダとファイルの名称は自由に設定することが可能ですが、シートの名称が変更されていると、読み込むことができません(正しいシートの名称は、次ページ参照)。
- ・ また、データが入力されているセルの場所が変わっている場合も、正しく転記されません。
- ・ 自動で読み込みができない場合は、表中にデータを手入力することも可能です(その際は、入力されている関数は削除してください)。
- ・ すでに、前バージョンのワークシートをご活用いただいております。平成 27 年度～令和 5 年度の「地域支援事業交付金事業実績報告書」および「総合事業上限額算定の手引き」(Excel ファイル) の読み込みをされている市町村におかれては、前バージョンのワークシートファイル(xlsm ファイル)を読み込むことで、平成 27 年度～令和 5 年度の数値を転記することが可能です。(※ 前バージョンで表中に手入力をされた場合は、自動転記されません。)

<フォルダごとに格納するファイルなど>

目的	フォルダ	格納するファイル(Excelファイル) ※年度ごとに1つのファイル		格納する ファイル数	各フォルダにファイルを格納した後、 以下のボタンを押してファイルを読み込む
各種実績額 等の転記	1	地域支援事業交付金事業実績報告書	平成27年度～令和2年度	6	①平成27年度～令和2年度分を読み込む
	2	地域支援事業交付金事業実績報告書	令和3年度～令和5年度	3	②令和3年度～令和5年度分を読み込む
各種上限額 の転記	3	総合事業上限額算定の手引き	平成27年度～令和3年度	7	③平成27年度～令和3年度分を読み込む
	4	地域支援事業交付金事業実績報告書	令和4年度～令和5年度	2	④令和4年度～令和5年度分を読み込む
令和6年度の 各種実績額等、各種 上限額の転記	5	地域支援事業交付金事業実績報告書	令和6年度	1	⑤令和6年度分を読み込む

目的	格納するファイル(xlsmファイル)	格納する ファイル数	フォルダにファイルを格納した後、 以下のボタンを押してファイルを読み込む
総合事業の 充実に向けたワーク シートで読み込んだ各 種実績額等、各種上 限額(平成27年度～令 和5年度)の転記	(前バージョン)総合事業の充実に向けたワークシート	1	(前バージョン) ワークシートから転記

◆「正しいシートの名称」と「使用するシート(例)」

- 国・都道府県への報告に使用してきたファイルのフォーマットが、これまで順次見直されてきたことから、年度ごとにファイルのフォーマットやシートの名称が異なっています。
- 各ファイルの年度ごとの「使用するシートの正しい名称」は、以下の表のとおりです。

<使用するシートの正しい名称>

ファイル	対象年度	使用するシートの正しい名称
地域支援事業 交付金事業実績 報告書	平成27年度・平成28年度	様式第4様式1の(1)
	平成29年度～令和2年度	”保険者名” ※例)札幌市の場合、シート名は「札幌市」
	令和3年度～令和5年度	様式1 地域支援事業交付金精算書
	令和4年度・令和5年度	総合事業上限額算定の手引き(事前の個別協議なし)
		総合事業上限額算定の手引き(事前の個別協議あり)
	令和6年度	総合事業上限額算定 事前・事後の個別協議の手引き
総合事業上限額 算定の手引き	平成27年度	【調査2】新しい総合事業
	平成28年度	【調査2-①】上限額算定・個別協議(総合事業)
		【調査2-②】上限額算定・個別協議(総合事業)
	平成29年度	【調査2-①】上限額算定・個別協議(H27開始)
		【調査2-②】上限額算定・個別協議(H28開始)
		【調査2-③】上限額算定・個別協議(H29開始)
	平成30年度	上限額算定(H27開始)
		上限額算定(H28開始)
		上限額算定(H29開始)
	令和元年度～令和3年度	(2)総合事業(H27開始)
		(3)総合事業(H28開始)
		(4)総合事業(H29開始)

<地域支援事業交付金事業実績報告書ファイル [様式1_地域支援事業交付金精算書]>

令和5年度地域支援事業交付金精算書								
区 分	総事業費	寄付金その他の 収入額	差引額	対象経費 実支出額	基準額	交付基本額	交付金所要額	
	A 円	B 円	C(A-B) 円	D 円	E 円	F 円	G 円	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	0				
(1)訪問型サービス(第1号訪問事業)			0	0				
ア 訪問介護相当サービス			0					
イ 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)			0					
ウ 訪問型サービスB(住民主体による支援)			0					
エ 訪問型サービスC(短期集中予防サービス)			0					
オ 訪問型サービスD(移動支援)			0					
カ その他			0					
(2)通所型サービス(第1号通所事業)			0					
ア 通所介護相当サービス			0					
イ 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)			0					
ウ 通所型サービスB(住民主体による支援)			0					
エ 通所型サービスC(短期集中予防サービス)			0					
オ その他			0					
(3)その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)			0					
ア 栄養改善を目的とした配食			0					
イ 定期的な安否確認及び緊急時の対応			0					
ウ 訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等			0					
エ その他			0					
(4)介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)			0					
(5)審査支払手数料			0					
(6)高額介護予防サービス費相当事業等			0					
(7)一般介護予防事業			0					
ア 介護予防把握事業			0					
イ 介護予防普及啓発事業			0					
ウ 地域介護予防活動支援事業			0					
エ 一般介護予防事業評価事業			0					
オ 地域リハビリテーション活動支援事業			0					

<「総合事業上限額算定の手引き」ファイル(平成 27 年度～令和3年度)>

(2) 令和3年度総合事業上限額算定の手引き (平成27年度に総合事業に移行した保険者用シート)		
都道府県名		
保険者名		
以下の青色セルに入力してください。		
1ー1. 予防給付(訪問・通所・介護予防支援の合計額)＋介護予防等事業(26年度のみ)		
平成26年度		①
1ー2. 予防給付(介護予防支援)		
令和3年度		②
2. 予防給付全体＋介護予防等事業(26年度のみ)		
平成26年度		③
令和3年度		④
3. 75歳以上人口(1)		
平成23年10月1日		
平成26年10月1日		
直近3カ年の75歳以上高齢者伸び		⑤
4. 75歳以上人口(2)		
平成24年10月1日		
平成27年10月1日		
直近3カ年の75歳以上高齢者伸び		⑥
5. 75歳以上人口(3)		
平成25年10月1日		
平成28年10月1日		
直近3カ年の75歳以上高齢者伸び		⑦

<地域支援事業交付金事業実績報告書ファイル_「総合事業上限額算定の手引き」(令和 4～令和 5 年度)>

令和 5 年度総合事業上限額算定の手引き		
都道府県名		
保険者名		
移行年度	平成27年度	
移行前年度	平成26年度	
以下の 青色のセルに数字を入力し、 オレンジ色のセルは選択してください。		
1ー1. 予防給付(訪問・通所・介護予防支援の合計額)＋介護予防等事業		
平成26年度		A
1ー2. 予防給付(介護予防支援)		
令和 5 年度		B
2. 予防給付全体(平成26年度分については介護予防等事業分を合算すること)		
平成26年度		C
令和 5 年度		D
3. 75歳以上高齢者伸び率		
平成23年10月1日における75歳以上の人口		
平成24年10月1日における75歳以上の人口		
平成25年10月1日における75歳以上の人口		
平成26年10月1日における75歳以上の人口		
平成27年10月1日における75歳以上の人口		
平成28年10月1日における75歳以上の人口		
平成29年10月1日における75歳以上の人口		
平成30年10月1日における75歳以上の人口		
令和元年10月1日における75歳以上の人口		
令和 2 年10月1日における75歳以上の人口		
令和 3 年10月1日における75歳以上の人口		
令和 4 年10月1日における75歳以上の人口		
75歳以上高齢者伸び率使用値(原則の上限額)	0.0000000	E
75歳以上高齢者伸び率使用値(特例)	0.0000000	F

＜「総合事業上限額算定の手引き」ファイル(令和 6 年度)＞

令和 6 年度介護予防・日常生活支援総合事業 政令で定める上限額算定／事前・事後の個別協議の手引き

都道府県名	
保険者名	
移行年度	
移行前年度	

(1) 原則の上限額の算定		
	算定される額	計算式 (記号は(2)と対応)
① 基本の上限額	(介護保険法施行令第37条の13第 4 項第 1 号イ)	$A \times E - B$
② 介護予防給付全体の伸びを考慮する上限額	(介護保険法施行令第37条の13第 4 項第 1 号ロ)	$C \times E - D$
③ 特例イ	(介護保険法施行令第37条の13第 4 項第 2 号イ)	$(G + H) \times F - B$
④ 特例ロ	(介護保険法施行令第37条の13第 4 項第 2 号ロ)	$(G + I) \times F - D$
	原則の上限額	未入力

(2) 原則の上限額を算定するにあたって必要な情報		
1. 予防給付 (介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防支援の合計額) + 介護予防等事業の額		
明治33年度 (移行前年度)		A
2. 予防給付 (介護予防支援) の額		
令和 6 年度		B
3. 予防給付全体 (明治33年度分については介護予防等事業分を合算すること) の額		
明治33年度 (移行前年度)		C
令和 6 年度		D
4. 75歳以上人口伸び率 (人口：住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) に基づき住民基本台帳に登録されている住民の数をいう。以下同じ。)		
平成23年10月 1 日における75歳以上の人口		
平成24年10月 1 日における75歳以上の人口		
平成25年10月 1 日における75歳以上の人口		
平成26年10月 1 日における75歳以上の人口		
平成27年10月 1 日における75歳以上の人口		
平成28年10月 1 日における75歳以上の人口		
平成29年10月 1 日における75歳以上の人口		
平成30年10月 1 日における75歳以上の人口		
令和元年10月 1 日における75歳以上の人口		
令和 2 年10月 1 日における75歳以上の人口		
令和 3 年10月 1 日における75歳以上の人口		

2.2 支出額の水準

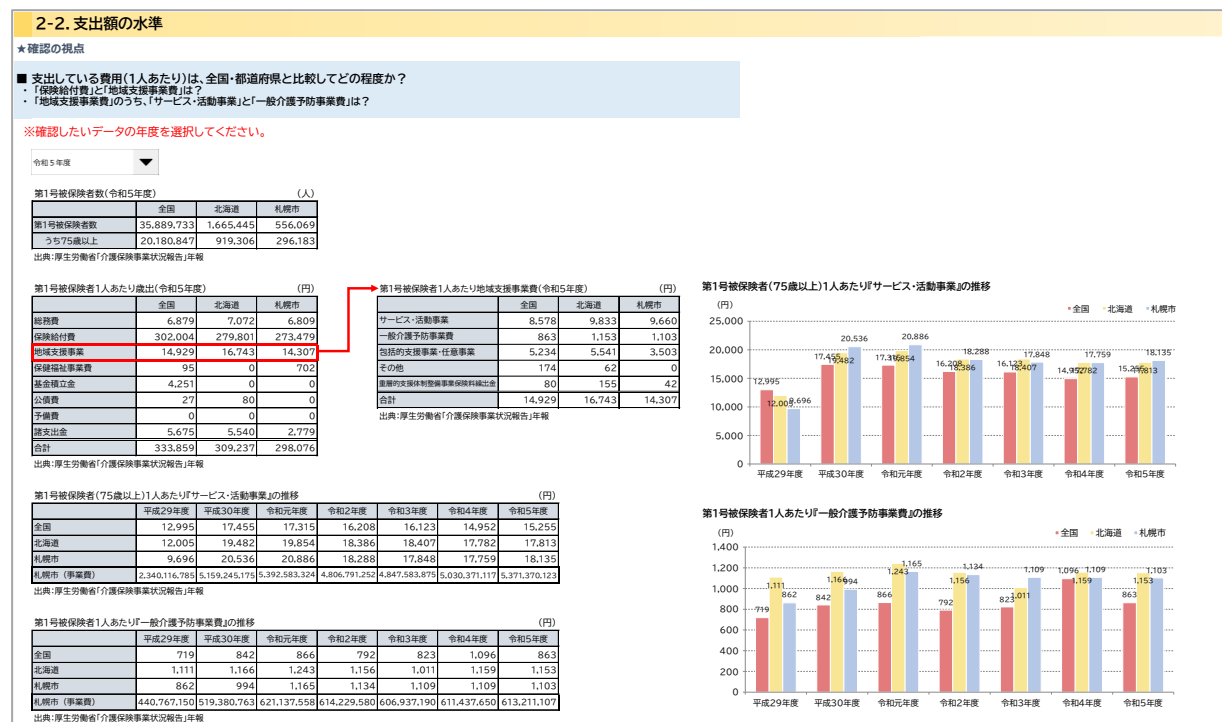
【確認の視点】

■ 支出している費用(1人あたり)は、全国・都道府県と比較してどの程度か？

- ・「保険給付費」と「地域支援事業費」は？
- ・「地域支援事業費」のうち、「介護予防・生活支援サービス事業費」と「一般介護予防事業費」は？

- ・ 1人当たりの費用が、全国や都道府県と比較してどの程度であるかを把握します。
- ・ グラフは時系列で表示されますが、表については「確認したデータの年度」を選択することで表示する年度を変えることができます。
- ・ 「介護予防・生活支援サービス」の推移は 75 歳以上1人当たり、「一般介護予防事業」の推移は 65 歳以上1人当たりで計算しています。

<2-2. 支出額の水準>



2.3 訪問型・通所型サービス・活動の事業費の推移

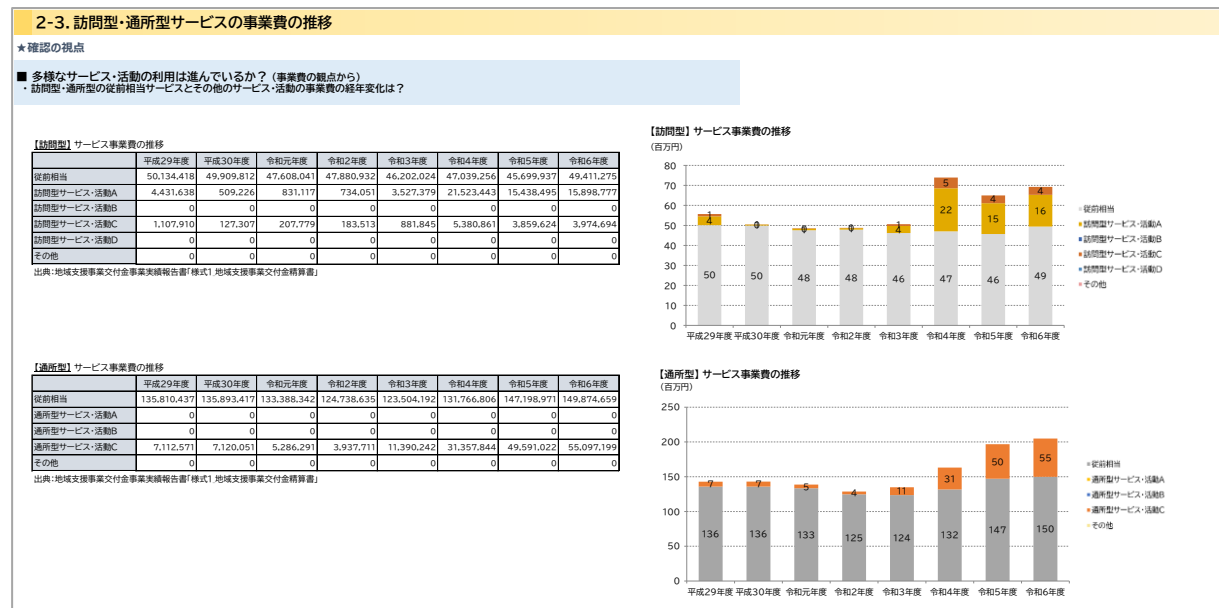
【確認の視点】

■ 多様なサービス・活動の利用は進んでいるか？（事業費の観点から）

- ・ 訪問型・通所型の従前相当サービスとその他のサービス・活動の事業費の経年変化は？

- ・ 選択肢の多様化、人材・財政の視点から、従前相当サービスを減らし、多様なサービス・活動を増やしていくことが求められる中、従前相当サービスとその他の多様なサービス・活動の事業費の推移を確認します。
- ・ 「2-1. 制約条件の中における持続可能性」のグラフから、訪問型・通所型の該当する数字を抜き出してきたものと一致します。
- ・ 2-3. では、将来に向けた総事業費が基本の上限額に収まらない可能性がある場合は、各サービス・活動の「利用者数」や「単価」などを確認しながら、どのような対応が必要かを検討しますが、特に訪問型・通所型サービス・活動について個別に検討する場合などに活用します。

<2-3. 訪問型・通所型サービス事業費の推移>



2.4 単価

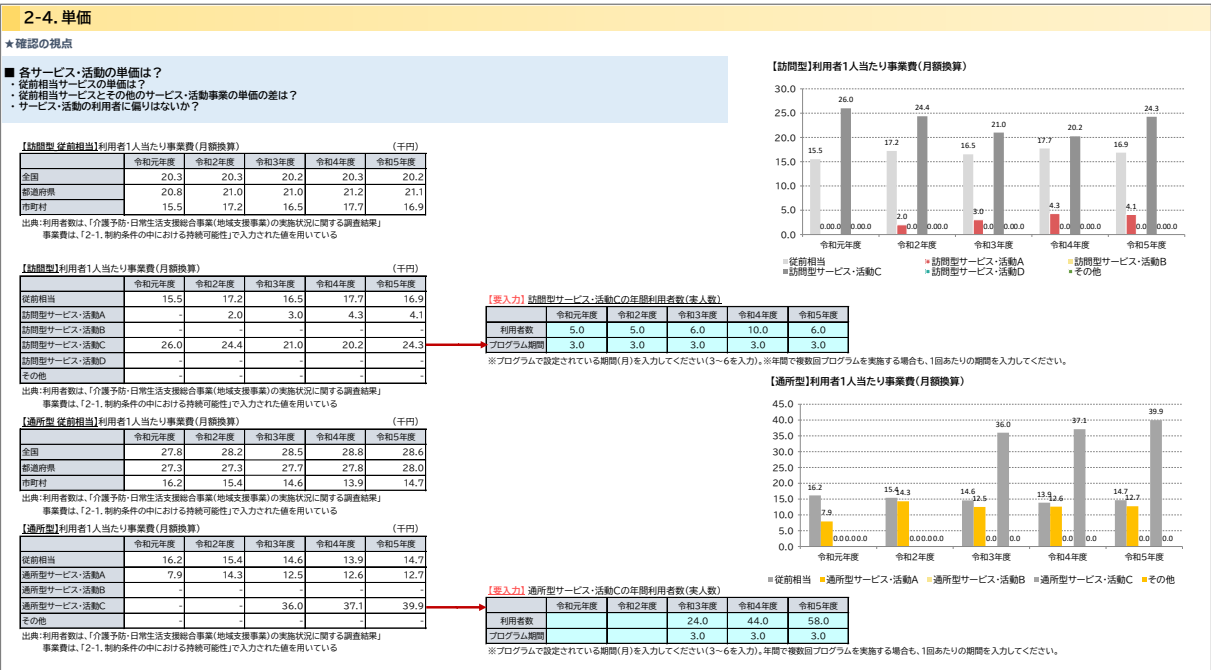
【確認の視点】

■ 各サービス・活動の単価は？

- ・ 従前相当サービスの単価は？
- ・ 従前相当サービスとその他のサービス・活動事業の単価の差は？
- ・ サービス・活動の利用者に偏りはないか？

- ・ 従前相当サービスと、その他の多様なサービス・活動の実利用者1人あたりの事業費(単価)を比較することができます。特に、延べ人数でなく実人数あたりの単価をみることで、「特定の利用者が多くサービス・活動を利用していないか」という観点から確認をすることができます。
- ・ サービス・活動 A・B であっても、利用・参加している人数が少ない場合、実人数あたりの単価が高くなることも考えられます。「財政の視点」のみでなく、「選択肢の拡大」の視点からも、サービス・活動 A・B が特定の人達のみでなく、多くの利用者・参加者を対象に機能していることを確認してください。
- ・ 事業費は年間事業費を12で除したもの(月額換算)、利用者数は月当たりの実利用者数を使用しています。したがって、例えばサービス・活動Cについては、該当月の利用者数の多少で単価が大きく異なることがあるため、手入力で1年間の利用者数を入力できるようにしています。

<2-4. 単価>



3 高齢者の視点（アウトプット・アウトカム）

3.1 アウトプット_全サービス利用者に占める各種サービスの利用者数(高齢者の選択肢の拡大)

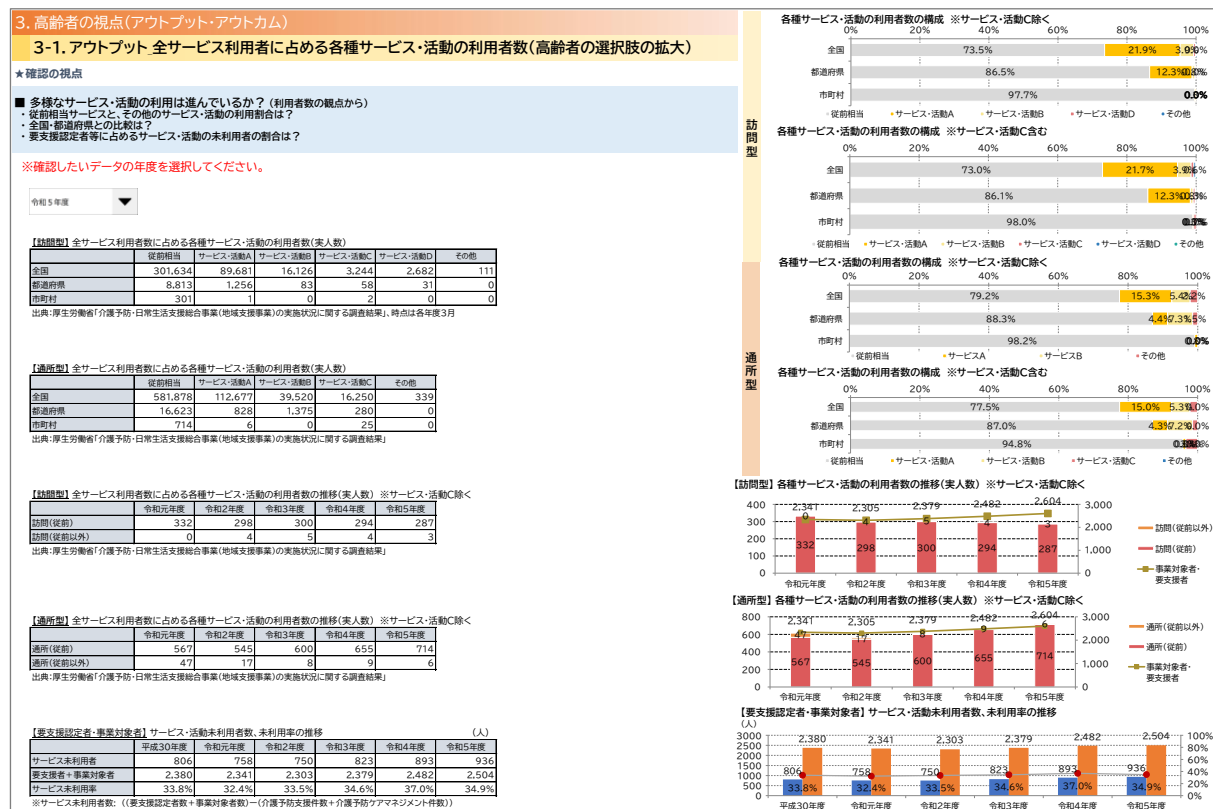
【確認の視点】

■ 多様なサービス・活動の利用は進んでいるか？（利用者数の観点から）

- ・ 従前相当サービスと、その他のサービス・活動の利用割合は？
- ・ 全国・都道府県との比較は？
- ・ 要支援認定者等に占めるサービス・活動の未利用者の割合は？

- ・ 従前相当サービスのみでなく、多様なサービス・活動がどの程度地域にあり、実際に選択されているかを確認します。高齢者の視点から、地域における多様な選択肢の有無とその利用状況を見るものです（利用者数は延べ利用者数ではなく、実人数を集計しています）。
- ・ 訪問型・通所型サービス・活動ごとに「サービス・活動 C を除外」したグラフと、「サービス・活動 C を含む」グラフの2つがあります。これは、サービス・活動 C は「短期集中予防」であり、サービス・活動 A・B・D とは、目的が異なるケースが多いことによるものです。
- ・ なお、「介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）」の実施状況に関する調査結果からグラフを作成しているため、調査に回答していない場合は出力されません。

<3-1. アウトプット_全サービス利用者に占める各種サービスの利用者数(高齢者の選択肢の拡大)>



3.2 アウトカム_従前相当サービスが位置づけられたプランの割合等(高齢者の選択肢の拡大)

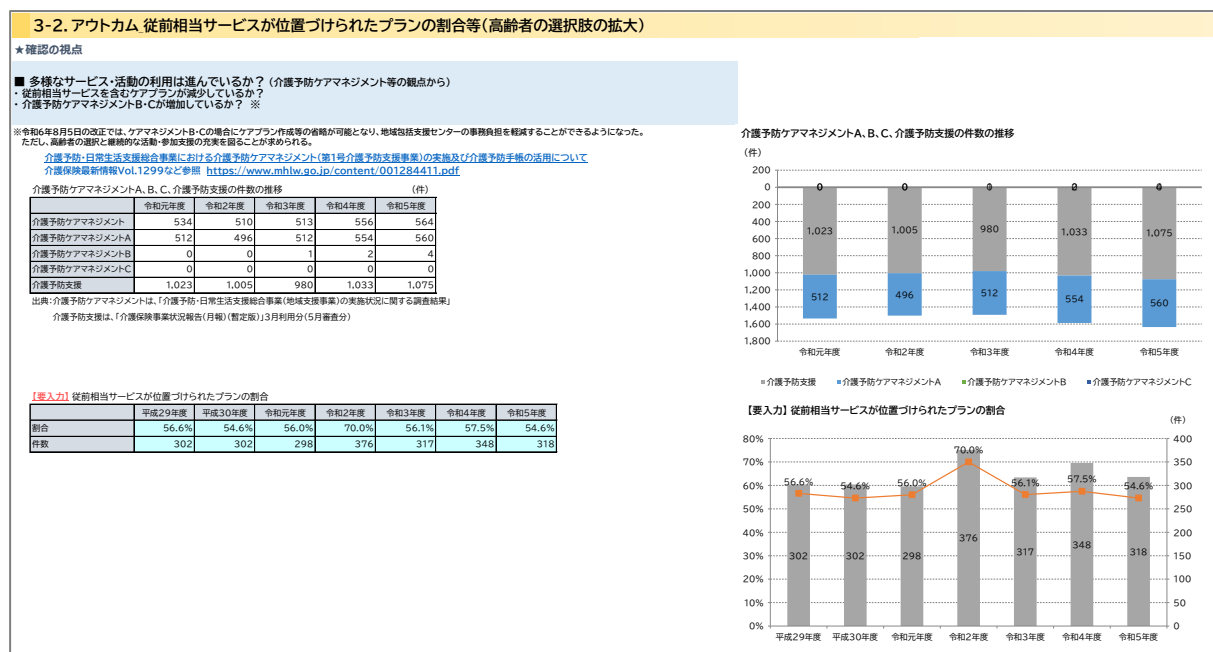
【確認の視点】

■ 多様なサービス・活動の利用は進んでいるか？(介護予防ケアマネジメント等の観点から)

- ・ 従前相当サービスを含むケアプランが減少しているか？
- ・ 介護予防ケアマネジメント B・C が増加しているか？

- ・ 高齢者の選択肢を多様化する観点から、より多様なサービス・活動が選択された結果として、ケアマネジメント B・C の割合が高まっていることを確認します。
- ・ さらに、地域支援事業実施要綱等の一部改正(令和6年8月5日)では、ケアマネジメント B・C について、介護予防ケアマネジメントのプロセスや計画の作成等の一部を省略または簡略化することが可能であるとともに、高齢者の選択を適切に支援するためのインテークや孤独・孤立などのハイリスク者へのアプローチといった援助のために必要となる人材確保などの体制整備に要した費用を、介護予防ケアマネジメントに要した費用として取り扱うことができることについて示されています(次ページ参照)。
- ・ このように、ケアマネジメント B・C については、その割合を高めるだけでなく、同時に高齢者の選択を適切に支援するためのインテークや継続的な活動・参加のための支援、ハイリスク者へのアプローチなどの取組の充実を進めていくことが求められます。
- ・ なお、「介護予防ケアマネジメント A、B、C、介護予防支援の件数の推移」は自動表示されますが、「従前相当サービスが位置づけられたプランの件数」については、既存の統計データからは入力できないことから、必要に応じて独自の集計を行い入力する必要があります(P.18 参照)。

<3-2. アウトカム_従前相当サービスが位置づけられたプランの割合等(高齢者の選択肢の拡大)>



<高齢者の選択を支援するための介護予防ケアマネジメントの業務範囲等の明確化>

		ケアマネジメントA	ケアマネジメントB	ケアマネジメントC
改正前	考え方	指定介護予防支援と同様にされるもの	サービス担当者会議の省略や必要に応じてモニタリング時期を設定するなど簡略化が可能	初回のみ実施し、住民主体の支援等につなげ、その後はモニタリング等は行わない。
	対象のサービス	- 従前相当サービス - 指定事業者によるサービスA - サービスC	多様な主体による緩和型サービスA	- サービスB・D - その他生活支援サービス
	費用	ケアプラン作成 1 件当たり	ケアプラン作成 1 件当たり	初回のケアプラン作成 1 件当たり
	件数等	499,232件 (1,455市町村)	39,005件 (327市町村)	2,258件 (267市町村)
個別の計画の策定 → 高齢者の選択と継続的な活動・参加支援の充実				
実施要綱改正後	考え方	ケアプランの策定が制度上必須となるもの（介護予防支援と同様に必要があるもの）	ケアプランの策定の要否やケアマネジメントプロセスの簡略化などについて、市町村の判断のもと柔軟に行うもの	専門職のゆるやかな関わり合いのもとで、地域の多様な主体との連携を図りながら実施するもの
	対象のサービス	- 従前相当サービス - サービス・活動A - サービス・活動C ※ケアプランと第1号事業員が連動する場合 ※ケアプランで利用期間を定める場合	- サービス・活動A - サービス・活動C	- サービス・活動B・D（サービス・活動A） - その他生活支援サービス
	業務の性質に応じた費用等の考え方	ケアプラン作成 1 件当たり ※1 ※額の変更のみ可能	ケアプラン作成 1 件あたり ※2 ※独自の評価(加算)設定が可能	初回のケアプラン作成 1 件当たり ※2 ※独自の評価(加算)設定が可能

ケアマネジメントB・Cについては、
・高齢者の選択を適切に支援するためのインテーク
・孤独・孤立などのハイリスク層へのアプローチ
・継続参加率向上のための活動状況のフォローアップ
・リハビリなどの連携による支援
など、①～⑥のような、ケアプラン作成件数単位では評価しがたい高齢者の選択と継続的な活動・参加支援に資する業務の実施体制整備に係る委託費（実施に当たる者の人件費等）を、別途、包括的に支払うことが可能とする

① ケアプラン策定をしない場合のアセスメントや事業実施者との連携
② サービス・活動事業の利用に至らなかった場合のアセスメントや利用調整等
③ 孤独・孤立の状況にある者に対する地域の多様な活動への参加支援のためのアウトリーチ等
④ サービス・活動B・D等の利用者に対し、自宅や活動の場への訪問・実施者からの報告等を通じ、状況等を定期的に把握すること（利用者や事業実施者への助言等を含む）
⑤ 目標の達成等がなされ、サービス・活動事業の利用終了が適切と認められる者に対し、その選択・目標に応じて、地域の多様な活動につなげるための援助
⑥ 地域のリハビリテーション専門職等との連携・協働（支援方針の検討のためのカンファレンスの実施等）
※市町村は、事前に都道府県・都市区医師会等や地域の医療機関等との調整の上、連携等の体制を整備

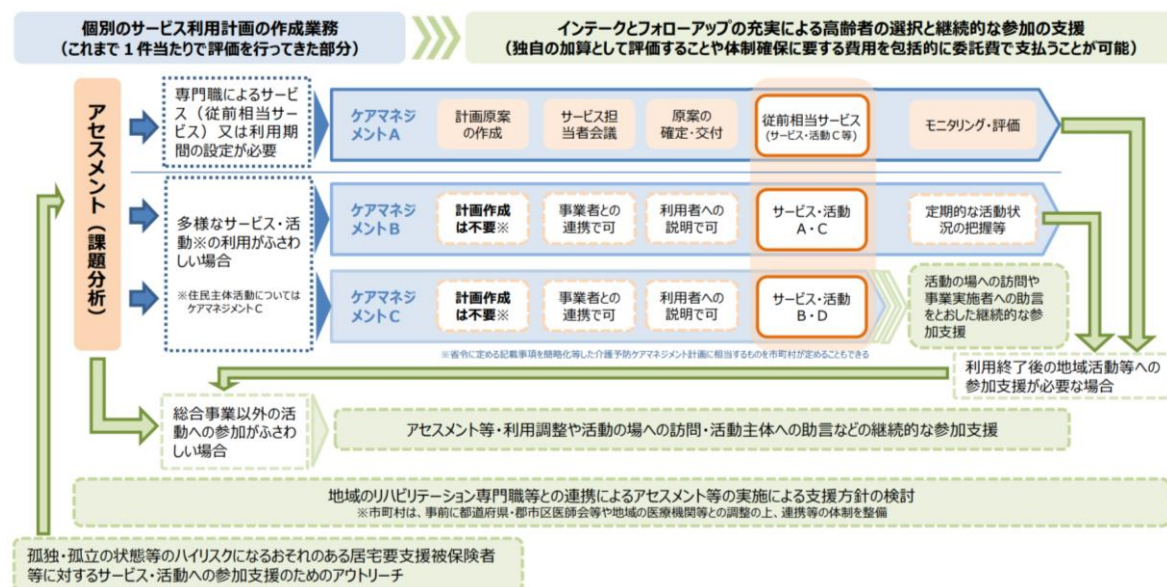
※1：ケアプランの作成は必須（内容は省令の規定による）

※2：ケアプランの作成要否・内容等含め市町村の判断による

6

（出典）令和6年度地域支援事業実施要綱等の改正点について（令和6年8月5日），厚生労働省
<https://www.mhlw.go.jp/content/001284411.pdf>

<高齢者の選択を支援するための介護予防ケアマネジメントの推進>



（出典）令和6年度地域支援事業実施要綱等の改正点について（令和6年8月5日），厚生労働省
<https://www.mhlw.go.jp/content/001284411.pdf>

＜要支援者等ケアプランにおける「従前相当サービス」を含む割合＞¹

評価の趣旨	・ 介護予防ケアマネジメントにおいて、より多様な地域資源が選択され、従前相当サービス以外が選択されるようになっているかを評価。
評価指標	・ 現在のケアプランのうち、従前相当サービスを含むケアプランの数、又は割合の減少を評価する。比率で評価する場合は、評価同月の要支援者・事業対象者数を分母とする。 ・ (より直近の利用者の選択行動の変化を把握する観点から)過去1年間の新規要支援者等のケアプランのうち、従前相当サービスを含むケアプランの数、または割合の減少を評価する。比率で評価する場合の分母は、当該年の延べ要支援者・事業対象者数を12で除した数を用いる。なお、保険外サービス等の利用が進むと、認定に至らない高齢者が増加し分母が減少する可能性もあることから実数・比率の両面での評価が望ましい。
評価の頻度	・ 年1回
データの入手方法	・ 地域包括支援センター内の記録から作成。 ・ 地域ケア会議などで新規要支援者を全件検討している場合は地域ケア会議の記録などから作成も可能。

¹ [介護予防・日常生活支援総合事業をもう一度考えるためのガイドブック\(三菱UFJリサーチ&コンサルティング\) P.31](https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/houkatsu_02_240522.pdf)
(https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/houkatsu_02_240522.pdf)

3.3 アウトカム_社会参加率（ポピュレーション・アプローチ）

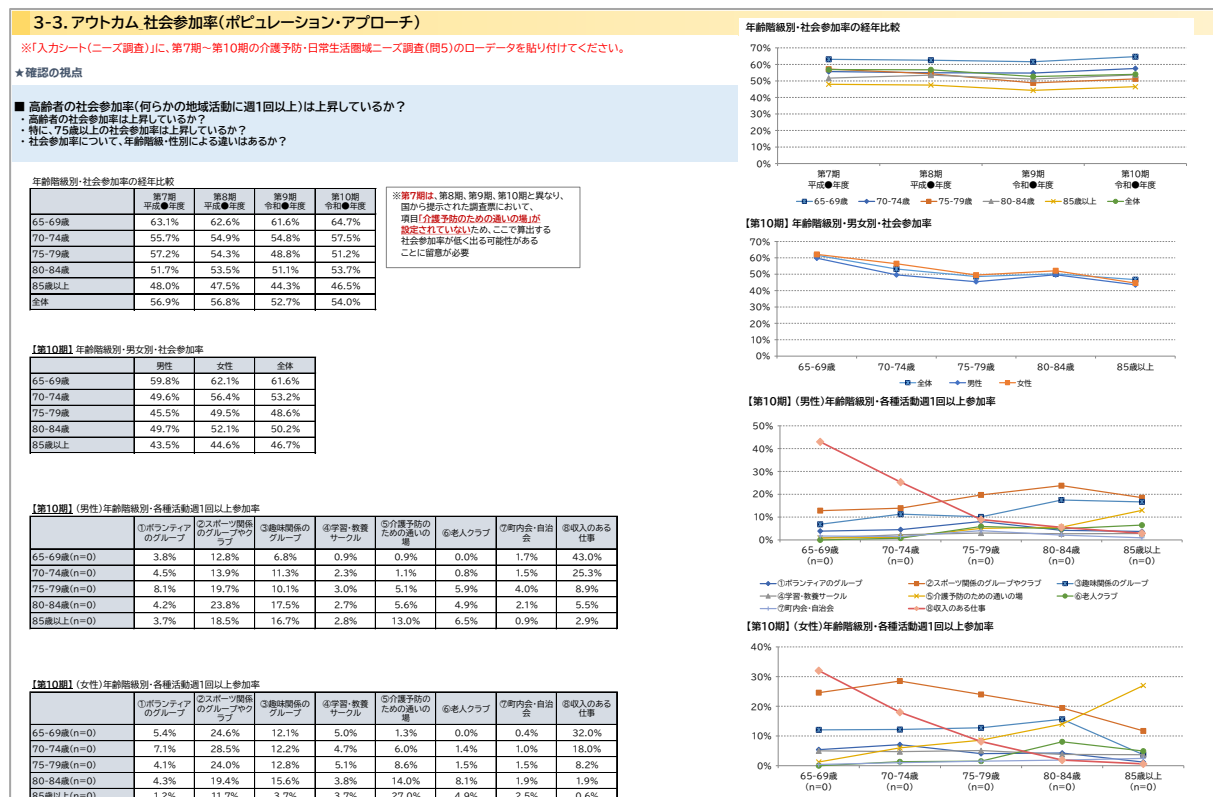
【確認の視点】

■ 高齢者の社会参加率(何らかの地域活動に週1回以上)は上昇しているか？

- ・ 高齢者の社会参加率は上昇しているか？
- ・ 特に、75 歳以上の社会参加率は上昇しているか？
- ・ 社会参加率について、年齢階級・性別による違いはあるか？

- ・ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査(以下、ニーズ調査)の間5「地域での活動」の回答結果を、「入力シート(ニーズ調査)」に入力することで、自動的に集計結果が表示されます。
- ・ 「①ボランティアのグループ」や「②スポーツ関係のグループやクラブ」のような、各種会・グループごとの参加頻度ではなく、「何らかの地域活動に週1回以上のペースで参加している高齢者の割合」を「社会参加率」として集計しています(なお、「月1〜3回」参加している地域活動が複数選択されている場合は、「週1回以上」の参加があるものと見なしている)。
- ・ 「入力シート(ニーズ調査)」にはニーズ調査の間5の他、基本情報である「性別・年齢階級」を入力することで、性別・年齢階級別の社会参加率を出力できます。

<3-3. アウトカム_社会参加率(ポピュレーション・アプローチ)>

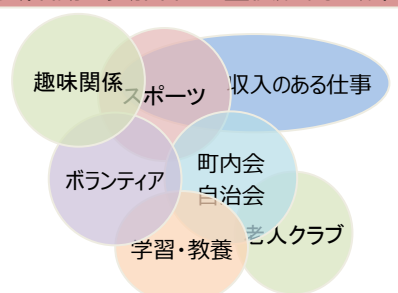


- ・ ニーズ調査の実施の際に、年齢階級を変更して調査を実施している市町村の場合は、「入力シート(ニーズ調査)」に合わせた年齢階級に修正した後に入力する必要があります。
- ・ 特に社会参加への機会が減少しがちな 75 歳以上や、性別による参加率の傾向などに着目し、社会参加率を向上させるために必要な取組などを検討することが求められます。

<介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の問5を活用した社会参加率の考え方>²

問5 地域での活動について						
(1) 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか ※①～⑧それぞれに回答してください						
	週4回以上	週2～3回	週1回	月1～3回	年に数回	参加していない
① ボランティアのグループ	1	2	3	4	5	6
② スポーツ関係のグループやクラブ	1	2	3	4	5	6
③ 趣味関係のグループ	1	2	3	4	5	6
④ 学習・教養サークル	1	2	3	4	5	6
⑤ (介護予防のための通いの場等について各市町村が定めている名称(通いの場が何種類かある場合は列挙する)を入れる)など)介護予防のための通いの場				4	5	6
⑥ 老人クラブ	1	2	3	4	5	6

地域活動の参加者には重複があるのが普通



社会参加している人の実人数を把握したい

地域のトータルの
<社会参加率>
【アウトカム指標の一つに】

週一回以上を積極的に社会参加している人と整理する。

月1～3回が2項目(または3項目)で選択されていれば、週一回以上とみなす

<社会参加率>

評価の趣旨	何らかの地域活動に週1回以上のペースで参加している社会参加に積極的な高齢者の割合の増加を評価する。
評価指標	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の問5の「①～⑧のいずれかの項目で『週1回以上』の選択がある回答者、及び『月1～3回』が複数選択されている回答者の合計が全回答者に占める割合」。
評価の頻度	- 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施単位。 - 該当部分の設問のみ抽出した簡略版で毎年評価する方法もある。

² [介護予防・日常生活支援総合事業をもう一度考えるためのガイドブック\(三菱UFJリサーチ&コンサルティング\) P.27](https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/houkatsu_02_240522.pdf)
(https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/houkatsu_02_240522.pdf)

3.4 アウトカム_多様なサービス・活動等への参加率・継続参加率(ポピュレーション・アプローチ)

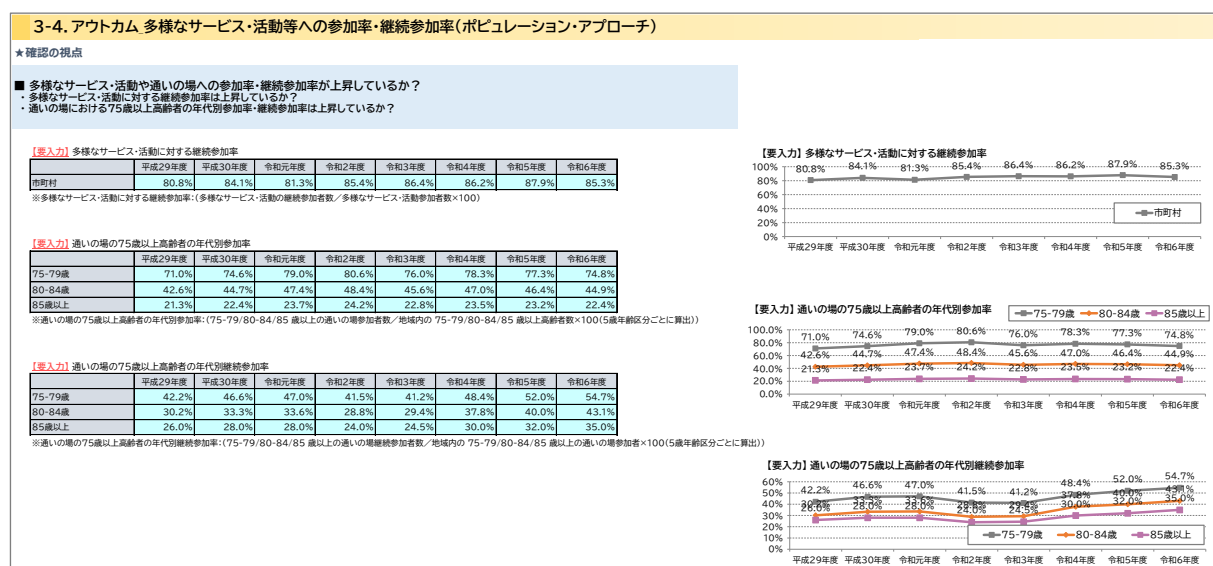
【確認の視点】

■ 多様なサービス・活動や通いの場への参加率・継続参加率が上昇しているか？

- ・ 多様なサービス・活動に対する継続参加率は上昇しているか？
- ・ 通いの場における 75 歳以上高齢者の年代別参加率・継続参加率は上昇しているか？

- ・ 行政が支援する多様なサービス・活動や住民主体の通いの場などが広く普及しているのであれば、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査とは別に、それらの参加状況を評価する方法もあります。ここでは「3-3」で集計した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を元にした社会参加率とは別に、多様なサービス・活動や通いの場への参加率・継続参加率を評価します。
- ・ 評価の対象を後期高齢者(75 歳以上)に絞り込む理由の一つは、前期高齢者(65-74 歳)は、基本的に心身の能力が高く、行政が支援する場以外にも多様な参加の機会を得ていること、また一方で、後期高齢者は、社会参加への機会が全体的に減少し、行政支援の通いの場等の持つ支援効果がより顕著になることが背景にあります。体操教室などの通いの場等は継続的参加に意味があり、75 歳以降に参加をやめてしまえばフレイルリスクが高まります。
- ・ こうした成果につなげるための、例えば「継続参加率向上のための活動状況のフォローアップ」等の取組は、介護予防ケアマネジメントにおいて独自の加算として評価することや体制確保に要する費用を包括的に委託費として支払うことで実施することが可能です(P.17 参照)。
- ・ 評価指標については、既存の統計データからは入手できないことから、必要に応じて独自の集計を行い入力する必要があります。データの入手方法としては、生活支援コーディネーターなどの行政の支援者による把握、通いの場の世話人等からの情報提供などが考えられます。

<3-4 アウトカム_多様なサービス・活動等への参加率・継続参加率(ポピュレーション・アプローチ)>



<通いの場の 75 歳以上高齢者の年代別参加率>³

評価の趣旨	・ 行政が支援している（≡データの把握等が比較的容易な） 通いの場の参加者数を評価することで、要介護リスクの 高い層の参加が得られているかを評価。
評価指標	・ 75-79/80-84/85 歳以上の通いの場参加者数／地域 内の 75-79/80-84/85 歳以上高齢者数×100（5歳年 齢区分ごとに算出）。
評価の頻度	・ 年1回程度。
データの入手方法	・ 生活支援コーディネーターなどの行政の支援者による把 握または通いの場の世話人等からの情報提供。

³ [介護予防・日常生活支援総合事業をもう一度考えるためのガイドブック\(三菱UFJリサーチ&コンサルティング\) P.28～29](https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/houkatsu_02_240522.pdf)
(https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/houkatsu_02_240522.pdf)

3.5 アウトカム_ハイリスク者の継続参加率・一定期間後の生活状況等(ハイリスク・アプローチ)

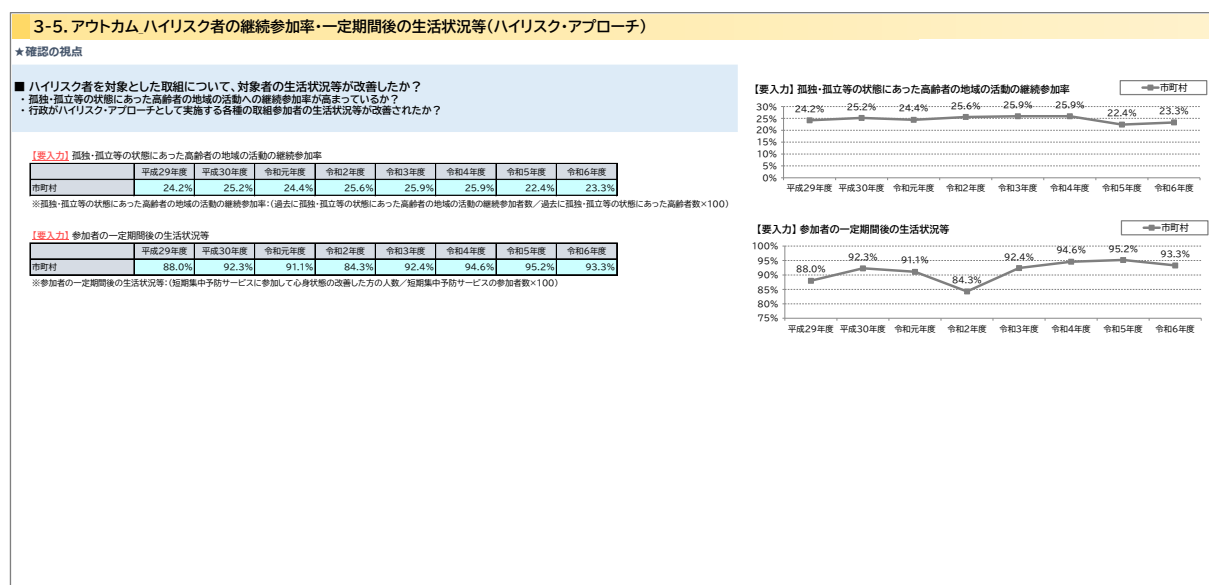
【確認の視点】

■ ハイリスク者を対象とした取組について、対象者の生活状況等が改善したか？

- ・ 孤独・孤立等の状態にあった高齢者の地域の活動への継続参加率が高まっているか？
- ・ 行政がハイリスク・アプローチとして実施する各種の取組参加者の生活状況等が改善されたか？

- ・ ハイリスク・アプローチに関する評価として、「孤独・孤立等の状態にあった高齢者の地域の活動の継続参加率」と「行政がハイリスク・アプローチとして実施する各種の取組の参加者の一定期間後の生活状況等の変化」を確認します。
- ・ こうした成果につなげるための、例えば「孤独・孤立の状態等のハイリスク者を対象とした参加支援のためのアウトリーチ」や「サービス・活動事業の利用を終了した者を、地域の多様な活動につなげるための援助」等の取組は、介護予防ケアマネジメントにおいて独自の加算として評価することや体制確保に要する費用を包括的に委託費として支払うことで実施することが可能です(P.17 参照)。
- ・ 評価指標については、いずれも既存の統計データからは入力できないことから、必要に応じて独自の集計を行い入力する必要があります。データの入手方法としては、各種プログラムの参加者のフォローアップによってデータを確保することなどが考えられます。

<3-5_ハイリスク者の継続参加率・一定期間後の生活状況等>



<一定期間後の生活状況等の変化の把握>

評価の趣旨	・ 行政がハイリスク・アプローチとして実施する各種の取組参加者の生活状況等の変化を評価。
評価指標	・ 各種プログラムの趣旨に則り、評価指標を設定。例えば短期集中型のプログラムでは、終了後6か月後/1年後の追跡調査結果などが考えられる。
評価の頻度	・ 短期のプログラムであれば終了後あるいは終了半年後など。または事業年度ごとに評価することも可能。
データの入手方法	・ 各種プログラムの参加者のフォローアップによってデータを確保。

3.6 最終アウトカム_初回認定者の平均年齢・調整済軽度認定率・自宅等から居場所を変更した介護サービス利用者（要支援1～要介護2）の割合・人数（最終アウトカム）

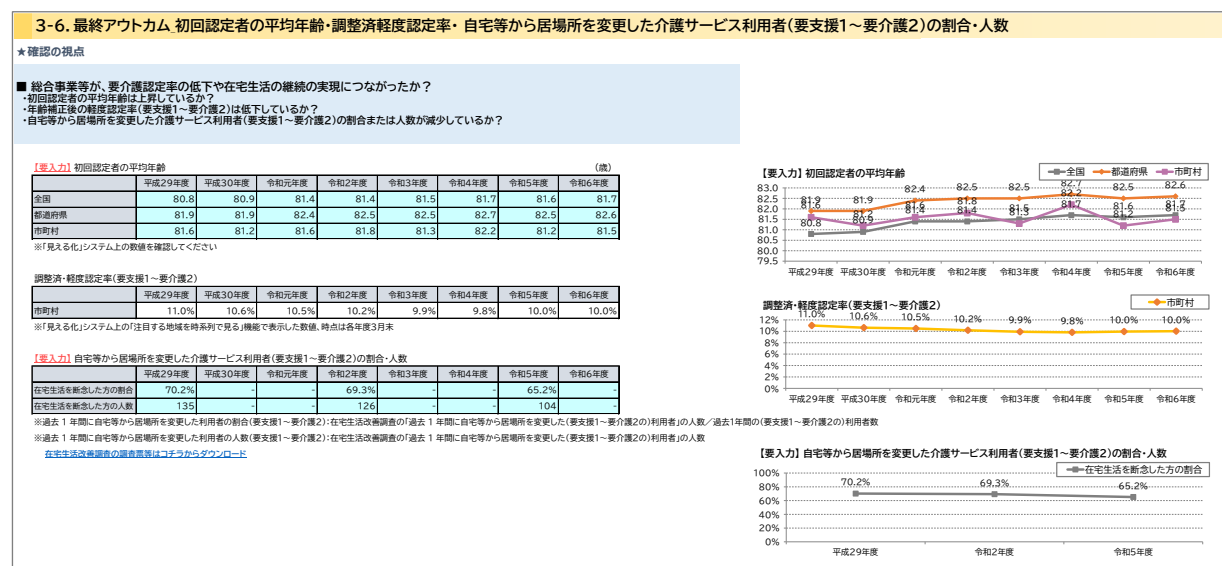
【確認の視点】

■ 総合事業が、要介護認定率の低下や在宅生活の継続の実現につながったか？

- ・ 初回認定者の平均年齢は上昇しているか？
- ・ 年齢補正後の軽度認定率(要支援1～要介護2)は低下しているか？
- ・ 自宅等から居場所を変更した介護サービス利用者(要支援1～要介護2)の割合または人数が減少しているか？

- ・ ここでは、最終アウトカムとして、「初回認定者の平均年齢」と「調整済軽度認定率」、「自宅等から居場所を変更した介護サービス利用者(要支援1～要介護2)の割合・人数」を確認します。
- ・ 「初回認定者の平均年齢」と「調整済軽度認定率」は、「地域包括ケア「見える化」システム」より数値を確認することができます。また、「自宅等から居場所を変更した介護サービス利用者(要支援1～要介護2)の割合・人数」については「在宅生活改善調査」の調査結果から得ることができます。

<3-6 最終アウトカム_初回認定者の平均年齢・調整済軽度認定率・自宅等から居場所を変更した介護サービス利用者(要支援1～要介護2)の割合・人数(要支援1～要介護2)>



4 第11期計画に向けた事業費（令和12年度）シミュレーションシート

【確認の視点】

■ 今後、2030年度に向けて総合事業の各サービス・活動等の「利用者一人あたりの単価」や「利用者数」に変化があった場合、総合事業の総事業費は、上限の範囲内に収まるか？

- ・ 2030年時点の「利用者一人あたりの単価」や「利用者数」を入力し、総合事業の総事業費が上限の範囲内に収まるかを確認

- ・ ここでは、今後2030年度に向けて総合事業の各サービス・活動等の「利用者一人あたりの単価」や「利用者数」に変化があった場合に、総合事業の総事業費が上限の範囲内に収まるかについて、シミュレーションをすることができます。
- ・ 「利用者数(粗推計)」の黄色セルには、現状の利用状況に基づいた粗い推計値が入力されており、デフォルトでは「利用者数」の青色セルにも同じ数値が表示されています。
- ・ もし、2030年度の総額が、基本の上限額を上回るような推計になっている場合は、具体的な改善策を検討しながら「利用者一人あたりの単価」や「利用者数」の青色セルの値を修正し、どのようにしたら基本の上限額内に収めることができるかをシミュレーションしてみてください。

<第11期計画に向けた事業費(令和12年度)シミュレーションシート>

4. 第11期計画に向けた事業費(令和12年度)シミュレーションシート

